

Meningite bacteriana · conduta inicial

Suspeita de meningite bacteriana é emergência: estabilize, colete o que puder sem atrasar e inicie antibiótico empírico imediatamente.

Clínica por faixa etária

- Lactente: irritabilidade, febre, fontanela abaulada, recusa, convulsão — rigidez pode faltar
- Criança maior: febre, cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, fotofobia, Kernig/Brudzinski
- Petéquias/púrpura: pensar meningococo — isolamento e ATB imediato

ATB empírico (ideia de prova)

Faixa | Esquema típico

Neonato | Ampicilina + cefotaxima (ou gentamicina conforme protocolo)

Lactente / criança | Ceftriaxona ou cefotaxima ± vancomicina (resistência pneumococo)

Imunocomprometido / risco *L. monocytogenes* | Associar ampicilina

Punção lombar

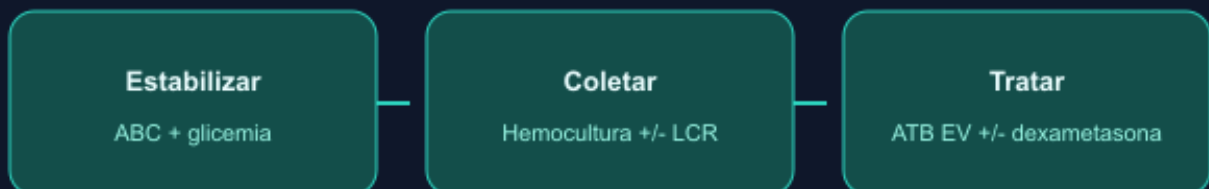
Lembre - Punção lombar

Se houver sinais de hipertensão intracraniana, instabilidade ou foco, faça imagem e NÃO atrase ATB — hemocultura + antibiótico primeiro.

Fluxo de prova: estabilizar !' coletar (se seguro) !' ATB ± corticoide.

Meningite bacteriana - 1a hora

Não atrase antibiótico



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Dexametasona (quando indicada) deve ser junto ou pouco antes da 1ª dose de ATB no pneumococo — atrasar perde o benefício na redução de sequelas.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Tríade clássica, corticoide no timing certo e ATB empírico por idade são o núcleo de meningite bacteriana pediátrica em prova.

Na criança maior: tríade. No lactente, irritabilidade, fontanela e convulsão podem substituir a rigidez.

Triade e sinais

Febre + cefaleia + rigidez

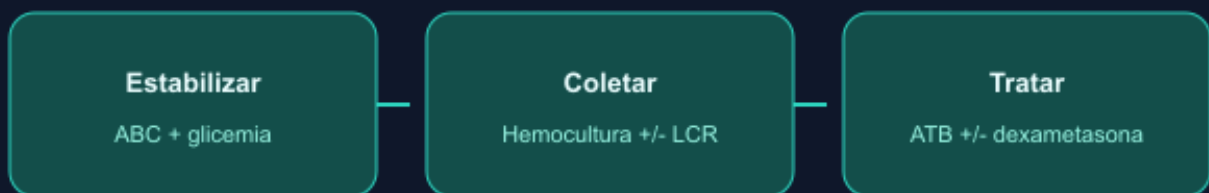
- 1 Febre
- 2 Cefaleia / vômitos
- 3 Rigidez de nuca
- 4 Kernig / Brudzinski
- 5 Fontanela abaulada (lactente)
- 6 Petequias / purpura

Petequias = meningococo até prova em contrário

Estabilizar !' coletar o possível !' ATB ± dexametasona sem demora.

1ª hora - meningite

Não atrase ATB



ATB empírico por idade (ideia de prova)

Faixa | Esquema típico | Cobertura-chave

Neonato | Ampicilina + cefotaxima (± genta) | GBS, E. coli, Listeria

Lactente/criança | Ceftriaxona/cefotaxima ± vancomicina | Pneumococo, meningococo, H. influenzae

Risco Listeria / imunossupressão | Associar ampicilina | L. monocytogenes

Dexametasona

- Indicação clássica: suspeita de pneumococo / meningite bacteriana comunitária na criança maior
- Dar junto ou pouco antes da 1ª dose de ATB
- Benefício principal: reduzir sequelas (ex.: surdez) no pneumococo
- Não atrase ATB se não puder puncionar imediatamente

Armadilha

Atenção - Armadilha

Sinais de HIC, instabilidade ou foco: imagem e ATB sem atrasar — hemocultura + antibiótico primeiro; PL quando seguro.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1